GRATIS

GLP-1:
Lo que necesitas saber antes de empezar

La guía gratuita para pacientes con Mounjaro o Wegovy que quieren resultados reales — y entender por qué pasan.

Dr. Cristian Ortiz
Bariatría, Obesidad y Nutrición | Monterrey, México
wa.me/528120318198

Este ebook es informativo y no sustituye la consulta médica. © Dr. Cristian Ortiz 2025

PARA EMPEZAR

Si llegaste aquí, ya estás haciendo algo bien.

Decidiste informarte — antes de actuar, o en medio de un tratamiento que quizás no está dando los resultados que esperabas. De cualquier forma, estás en el lugar correcto.

Los GLP-1 son la herramienta más poderosa que tenemos hoy para tratar la obesidad. Pero también son los medicamentos más malentendidos. La mayoría de los pacientes los usa sin saber exactamente qué hacen, qué esperar ni qué tienen que poner de su parte. Esa brecha de información es la que separa a quienes transforman su cuerpo de quienes se frustran y abandonan.

Este ebook es lo que te diría en consulta, de frente, sin rodeos.

01 Cómo funciona realmente el GLP-1

02 Qué comer para no perder músculo

03 Por qué te estancas (y cómo salir)

CAPÍTULO 01

¿Cómo funciona realmente el GLP-1?

El GLP-1 no es "una pastilla para adelgazar con inyección". Es una hormona que tu propio cuerpo produce cuando comes, cuya función es decirle a tu cerebro: *ya estás lleno, para de comer.*

En personas con obesidad, esa señal está dañada. No es falta de voluntad — es bioquímica. Los análogos como la semaglutida (Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro) amplifican esa señal de forma sostenida y poderosa.

¿Qué cambia en tu cuerpo con el medicamento?

- ✓ **Menos hambre:** El cerebro recibe señales más claras de saciedad. Comes menos sin sentir que haces una dieta de castigo.
- ✓ **Digestión más lenta:** El estómago tarda más en vaciarse, manteniéndote satisfecho por más tiempo y reduciendo picos de azúcar.
- ✓ **Menos antojos de azúcar:** Especialmente con tirzepatida. Muchos pacientes lo describen como la libertad más grande que han sentido en años.
- ✓ **Mejor manejo de insulina:** Mejoran la respuesta del páncreas a la glucosa. Fundamental si tienes diabetes tipo 2 o prediabetes.
- ✓ **Protección cardiovascular:** Wegovy tiene indicación aprobada para reducir eventos cardiovasculares. No solo adelgazan — protegen el corazón.

Mounjaro vs Wegovy — la diferencia clave

Medicamento	Receptores	Pérdida promedio
Semaglutida (Wegovy)	GLP-1	15–17%
Tirzepatida (Mounjaro)	GLP-1 + GIP	20–22%

CAPÍTULO 02

¿Qué comer para no perder músculo?

Este es el error más costoso que veo en consulta. El medicamento reduce tu hambre — eso lo logra solo. El problema es **qué comes** con esas calorías reducidas.

Cuando la ingesta baja un 30–50% y la proteína no es suficiente, el cuerpo pierde músculo en lugar de grasa. Perder músculo es peor que no bajar nada, porque el músculo es el tejido que más calorías quema en reposo.

25–40% del tejido que pierdes puede ser músculo si no consumes suficiente proteína. Con la ingesta adecuada, esa cifra baja al **10–15%**.

La regla más importante: Proteína primero

La recomendación basada en evidencia es **1.2 a 1.6 g de proteína por kg de peso al día** — entre 90 y 130 g diarios para la mayoría de los pacientes. En cada comida, la proteína va antes que cualquier otra cosa.

¿Qué alimentos priorizar? (Dieta de la Milpa + Mediterránea)

✓ SÍ — Consume diario	✗ LIMITAR o EVITAR
• Pollo y pavo a la plancha • Res magra, milanesa de res • Huevos y claras de huevo • Atún y sardinas en agua • Frijoles, lentejas, habas • Nopal, calabaza, chayote • Yogur griego natural • Queso panela o fresco • Aguacate, nuez, almendra • Tortilla de maíz (1–2/comida)	• Refrescos, jugos y aguas frescas • Pan dulce, galletas, pasteles • Frituras y botanas empacadas • Embutidos (chorizo, salchicha) • Arroz blanco en exceso • Alcohol (cerveza, vino, licor) • Ultraprocesados "light" o "fit" • Azúcar, miel, piloncillo • Carnitas, chicharrón • Bebidas energéticas

Tip clínico: Bebe agua 30 minutos ANTES de comer — no durante. El agua ocupa espacio en el estómago y puede desplazar la proteína antes de que hayas comido suficiente.

CAPÍTULO 03

¿Por qué te estancas?

"El medicamento ya no me hace efecto." Es lo que me dicen. Casi nunca es lo que realmente pasa.

El **plateau** (estancamiento de peso: cuando la báscula deja de moverse aunque sigas tomando el medicamento y comiendo bien) es una respuesta normal del cuerpo. No significa que el tratamiento falló — significa que el cuerpo se adaptó y necesita un ajuste.

01 **Calorías líquidas invisibles:** Café con azúcar, aguas frescas, refrescos, alcohol. Un paciente hacía todo perfecto y tomaba 400 kcal al día que no contaba. Al eliminarlas, la báscula se movió de nuevo.

02 **Falta de masa muscular:** Cada kg de músculo quema 13–15 kcal/día en reposo. Sin ejercicio de fuerza 2–3 veces/semana, el metabolismo baja y el plateau (estancamiento) llega antes y dura más.

03 **Sueño de mala calidad:** Dormir menos de 6 horas eleva el cortisol y el hambre, y reduce la saciedad. Esto contrarresta directamente parte del efecto del GLP-1.

04 **Condiciones no tratadas:** Hipotiroidismo sin control, síndrome de ovario poliquístico (SOP) o resistencia severa a la insulina. Actúan como frenos invisibles que ningún medicamento puede vencer solo.

05 **Dosis insuficiente:** Si llevas meses en la misma dosis sin resultados, puede ser momento de ajustarla. Pero esto requiere evaluación médica — no cambios a ciegas.

06 **Recomposición corporal silenciosa:** A veces hay plateau (la báscula no baja) porque estás perdiendo grasa y ganando músculo al mismo tiempo. Pesas igual, pero tu cuerpo cambió. Por eso nunca se evalúa el tratamiento solo con el peso.

¿Cuándo consultar de inmediato?
Más de 4 semanas de plateau (estancamiento) con buena adherencia · Náuseas persistentes después de 15 días en nueva dosis · Dolor abdominal intenso · Mareos o hipoglucemia · Pérdida severa de cabello.

LO QUE NADIE TE DICE

El rebote: los números reales

Después de suspender los GLP-1 sin un plan de mantenimiento, la mayoría de los pacientes recupera una parte importante del peso perdido en el primer año. No porque el medicamento falle — sino porque la obesidad es una enfermedad crónica con mecanismos biológicos que no desaparecen al suspender el fármaco.

Medicamento	Pérdida durante tx	Recuperado al año
Wegovy (Semaglutida)	17.3%	11.6%
Mounjaro (Tirzepatida)	20.9%	~14%

Pero el rebote no es inevitable. Es predecible — y cuando es predecible, se puede planear. Los pacientes que mantienen resultados usaron el tiempo con el medicamento para construir hábitos reales: masa muscular, mejor relación con la comida y sueño reparador. Y cuando suspendieron, lo hicieron con un plan claro.

Lo que sí funciona — los 4 pilares

1. **Proteína primero:** En cada comida, la proteína va antes. Pollo, res magra, huevos, frijoles, atún. Protege el músculo, mantiene la saciedad y tiene el mayor efecto térmico.
2. **Ejercicio de fuerza:** Sin al menos 2–3 sesiones semanales de entrenamiento de resistencia muscular, dejas la mitad del potencial del tratamiento sobre la mesa.
3. **Sueño de calidad:** 7–9 horas no es un lujo — es parte del protocolo. Los pacientes que optimizan su sueño pierden más grasa y retienen más músculo.
4. **Seguimiento médico real:** Permite ajustar la dosis en el momento correcto, detectar señales de alarma y adaptar el plan cuando el cuerpo se adapta. Con seguimiento, los resultados son consistentemente mejores.

La información sola no mueve la báscula.

Si llegaste hasta aquí, ya tienes más información sobre GLP-1 que la mayoría de las personas que los usan.

Lo que marca la diferencia es un plan personalizado, bien ejecutado, con alguien que te guíe.

Agenda tu consulta con el Dr. Ortiz

Evaluación completa · Plan personalizado · Seguimiento real

Escríbeme por WhatsApp

Escribe "Quiero mi consulta" y te respondo personalmente.

Únete a nuestra comunidad:

Únete a la comunidad en Facebook

Dr. Cristian Ortiz | Bariatría, Obesidad y Nutrición | Monterrey, México
Dr. Cristian Ortiz | Bariatría, Obesidad y Nutrición | Monterrey, México

Este ebook es informativo y no sustituye la consulta médica. © Dr. Cristian Ortiz 2025

EDICIÓN PREMIUM 2025

Ya terminaste la guía gratuita.

La versión completa va mucho más lejos.

	✦ Guía Gratuita	✦ Edición Premium
Capítulos	3 capítulos	**15 capítulos + herramientas**
Cómo funciona el GLP-1	✓ Básico	**✓ Profundo + oral + 2026**
Estancamiento (plateau)	6 causas	**7 factores + casos reales**
GLP-1 en mujeres / SOP	✗ No incluido	**✓ Capítulo completo**
Tu cerebro con GLP-1	✗ No incluido	**✓ Adiciones, ánimo, ciencia**
Sistema de clicks	✗ No incluido	**✓ Alerta con datos oficiales**
Costos y falsificaciones	✗ No incluido	**✓ Guía de compra segura**
Lo que viene en 2026	✗ No incluido	**✓ Nuevos fármacos y precios**
Tracker + Calculadora	✗ No incluido	**✓ 3 herramientas clínicas**
Referencias científicas	✗ No incluido	**✓ 25+ fuentes 2024-2025**

La guía gratuita te dio el mapa. La Premium te da el GPS.

Quiero la Edición Premium →

hotmart.com — GLP-1: Lo que nadie te dice antes de usarlos

Este ebook es informativo y no sustituye la consulta médica. © Dr. Cristian Ortiz 2025